

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LIEBE HANDBUCHGEFÜLLT
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 29 (neu)	Bezeichnung des Dokumentes: Umgang mit Schmerzen in Anlehnung an den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen“ (2014)	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)
- Pflegerische Schmerzexperten

Ziel der Maßnahme:

„Jeder Patient mit chronischen Schmerzen erhält ein individuell angepasstes Schmerzmanagement, das zur Schmerzlinderung, zu Erhalt oder Erreichung einer bestmöglichen Lebensqualität und Funktionsfähigkeit sowie zu einer stabilen und akzeptablen Schmerzsituation beiträgt und schmerzbedingten Krisen vorbeugt.“

Grundsatz: Aus akuten Schmerzen können durch das ausgeprägte Schmerzgedächtnis chronische Schmerzen entstehen.

Indikation:

- bei andauernden oder intermittierenden Schmerzen (zeitweise unterbrochenen, jedoch immer wiederkehrenden Schmerzen jedweder Genese/Entstehung insbesondere chronischen und tumorbedingten Schmerzen)
- zur Erreichung einer stabilen Schmerzsituation
- zur regelmäßigen Kontrolle der Schmerzsituation bzw.
- nach ärztlicher Anordnung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten

Vorbereitung:

- Patient informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- Wong-Baker-Skala (WBS) als Selbsteinschätzung
- Nachweis Bewertung von Schmerzen bei Demenz (BESD) als Fremdeinschätzung
- Medikamente nach ärztlicher Anordnung
- Materialien für die nicht-medikamentöse Schmerztherapie

Durchführung:

- zu Beginn (bei Aufnahme) erfolgt eine Informationssammlung von Problemen und Ressourcen des Patienten durch die PFK in den Themenfeldern der „Strukturierten Informations Sammlung“ (SIS).
- daraus ergibt sich eine erste pflegefachliche Einschätzung, die in der Risikomatrix „Erste fachliche Einschätzung der für die Pflege und Betreuung relevanten Risiken und Phänomenen“, mit ja oder nein beantwortet/angekreuzt werden muss
- erste pflegefachliche Einschätzung Kennzeichnung „nein“:
liegt keine Schmerzsituation vor, werden keine Maßnahmen geplant und umgesetzt.
- erste pflegefachliche Einschätzung Kennzeichnung „ja“:
muss die PFK zusätzlich eine Entscheidung treffen, ,
 - ob es sich hier um einen chronischen oder akuten Schmerz handelt,
 - sowie ob er stabil oder instabil ist.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE V.D. GEMEINSCHAFT DER KRANKENPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 29	Bezeichnung des Dokumentes: Umgang mit Schmerzen in Anlehnung an den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen“ (2014)	

- Ist dies geschehen und sind aus pflegefachlicher Sicht keine ärztlichen Maßnahmen oder Verlaufsbeobachtungen notwendig, so kann die Kategorie „weitere Einschätzung notwendig“, mit „nein“ angekreuzt werden.
- Kann die PFK zu Beginn die Ausprägung noch nicht einschätzen, wird die Kategorie „weitere Einschätzung notwendig“ mit „ja“ angekreuzt, um festzulegen, dass hierzu aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit für ein weiteres Handeln besteht.
- Eine Information und Abstimmung mit dem Arzt (schriftlich/telefonisch) und eine Verlaufsbeobachtung hat zu erfolgen.
- Es sind die dargestellten Risiken und Ursachen des aktuellen Nationalen Expertenstandards heranzuziehen ggfls. ist die Maßnahmenplanung anzulegen oder anzupassen.
- Wurde ein Risiko erkannt hat eine Beratung des Patienten/Angehörigen oder Betreuer zu erfolgen
- Grundsätzlich dient der Pflegebericht zur Erfassung der Schmerzverlaufes, veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen
- Bei Patienten SGB V erfolgt die Erhebung nur im Rahmen des Risikomanagements bei erheblichen Schmerzzuständen bzw. auf ärztliche AO.
- Die pflegerische Einschätzung orientiert sich an den Grunderkrankungen und Schmerzsituationen und ist Teil der Krankenbeobachtung.
- Die PFK stellt fest, ob es sich bei chronischen bzw. tumorbedingten Schmerzen um eine stabile oder eine instabile Schmerzsituation handelt.
- Bei instabilen Schmerzsituationen ist der Arzt einzubeziehen. Instabil ist eine Schmerzsituation bei folgenden Bedingungen: die Schmerzsituation bzw. -linderung entspricht dauerhaft nicht der akzeptablen Intensität des ertragbaren Schmerzes; Häufung alltagsbezogener Krisen; Versorgungsbrüche die im Rahmen der Selbstmanagementkompetenzen nicht überbrückt werden können, Komplikation durch die Therapie oder Nebenwirkungen, Einbußen von Lebensqualität, Funktionalität oder sozialer Teilhabe unter besonderer Berücksichtigung der langsamen Verschlechterung des Gesundheitszustandes.
- Die Wong-Baker-Skala (WBS) ist **durch die PFK** grundsätzlich bei allen Patienten anzuwenden, die über Schmerzen klagen und mit dieser Skala noch umgehen können.
- Der Patient zeigt auf das jeweilig für ihn subjektiv zutreffende Gesicht auf der Skala, die Pflegekraft liest den Wert unter dem Gesicht ab. Wenn die PHK Schmerzen beim Patienten feststellt informiert diese umgehend die PFK.
- **Merke:** Wir respektieren die Feststellung und Äußerungen des Patienten über seine Schmerzsituation.
- Wir orientieren uns am bio-psycho-sozialen Modell und berücksichtigen im Sinne von „total pain“ an physiologischen, psychischen, sozialen und spirituellen Aspekten.
- Bei Notwendigkeit ist ein/e „ pflegerische/r Schmerzexpert/e/in“ hinzuzuziehen
Als „ pflegerische/r Schmerzexpert/e/in“ ist in unserem Dienst: eingesetzt, sie/er verfügt über eine spezielle Weiterbildung, koordiniert notwendig werdende Schmerzkonsile (Fallbesprechungen), unterstützt die PFK und arbeitet eng mit dem Arzt zusammen.
- Bei der Gabe der Medikamente soll eine erneute Schmerzbewertung durch die PF eine Stunde nach der oralen Aufnahme, nach ½ Stunde bei Infusionen bzw. 12 Stunden nach der transdermalen Gabe erfolgen, mindestens jedoch beim nächsten Einsatz um die Wirksamkeit der Dosis zu bewerten. Ziel ist es den Wert der akzeptablen Intensität des

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE HILFE LIEBEN WACHSAM WACHTUN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 29	Bezeichnung des Dokumentes: Umgang mit Schmerzen in Anlehnung an den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen“ (2014)	

ertragbaren Schmerzes zu erreichen und zu unterschreiten, die Anpassung der Dosis hat in Abstimmung mit dem Arzt zu erfolgen.

- Die PFK steuert die Zusammenarbeit mit dem pflegerischen Schmerzexperten im Pflegedienst bzw. mit anderen externen Berufsgruppen und teilt im Rahmen des Entlassungsmanagements den aufnehmenden Einrichtungen und Diensten die Informationen zur Schmerzsituation des Patienten mit.
- Die Maßnahmenplanung stellt den individuellen Behandlungsplan mit medikamentösen und nicht-medikamentösen Maßnahmen dar (**Beachte:** Bei chronischen Schmerzen ist es anders als bei akuten Schmerzen nicht möglich Zielvorgaben allgemeingültig festzulegen, es sind ausgehandelte Ziele zu vereinbaren bspw. wie hoch ist der ertragbare Schmerz bzw. wie hoch ist das Ziel in Mobilität oder bei Freizeitaktivitäten).
- Die zu vereinbarenden Maßnahmen sollen sich an der Alltagsroutine und den Lebensweltkontexten sowie Gewohnheiten der Patienten orientieren, individuelle Tagesabläufe sind zu berücksichtigen.
- In unserer Arbeit berücksichtigen wir die „Ethik-Charta“ der Deutschen Gesellschaft zur Studium des Schmerzes e.V.

Maßnahmen im Rahmen des Schmerzmanagements sind:

- Das Selbstbestimmungsrecht ist zu beachten.
- Merke! Nichtmedikamentöse Maßnahmen der Schmerztherapie ersetzen eine medikamentöse Schmerztherapie nie, sie können diese nur ergänzen. Mit dem Arzt ist hinsichtlich der Gabe von Schmerzmedikamenten eng zusammen zuarbeiten. Die PFK stimmt sich mit dem Arzt bei Notwendigkeit zu Änderungen im Schmerzschema ab, um Unter-, Über- und Fehlversorgung zu vermeiden. Dies betrifft auch die Gefahr der Obstipation, des Delir bzw. die Gefahr der Suchtabhängigkeit. Die Umsetzung ist für uns im Standard „Umgang mit Medikamenten“ geregelt, ebenso der Umgang mit BTM.
- Die Krankenbeobachtung hat des Weiteren das Ziel Nebenwirkungen (wie Pharmakokinetik und -dynamik als Verteilungsfähigkeit und Verteilungsgeschwindigkeit von Medikamenten, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, Wirkungsbeginn/-dauer/ und –spitze, starke Müdigkeit, Grunderkrankungen, Alter, Gewichtsveränderungen, körper- und krankheitsbezogene Veränderungen, Allergien gegen Inhaltsstoffe, asymptomatische Magengeschwüre etc.) zu erkennen und situationsgerecht zu handeln.
- Der Beipackzettel der Medikamente ist zu beachten.
- Bei Obstipationsgefahr ist nach dem für uns geltenden Standard zu verfahren.
- Ein besonderer Schwerpunkt bildet die Schmerzprophylaxe bei erwartbaren Schmerzen (bspw. bei Handlungen, die beim Patienten mit Schmerzen einhergehen können), hier sind pflegerische Tätigkeiten erst nach voller Entfaltung der Wirkung des Schmerzmittels umzusetzen. In Abstimmung mit dem Arzt ist darauf hinzuwirken, dass bei Möglichkeit ein nicht-retardierendes Schmerzmittel (Mittel ohne verzögerte Wirkung) einzusetzen ist.
- Die Anzeichen für ein Delir sind nach Operationen, nach Verletzungen und bei BTM-Gabe besonders zu beachten.
- Im Rahmen der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen kann es auch sein, dass Patienten Schmerzen aushalten wollen, um möglichst noch viel am Leben teilnehmen zu können.
- **Beachte:** Nicht jedes Schmerzmittel wirkt bei jeder Schmerzart. Mit der Chronifizierung der Schmerzen können Schmerzmittel, die zuvor eine gute Wirkung erzielt haben, keine Wirkung mehr zeigen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE VON LEBEN WERDEN SICH BEWAHREN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 29	Bezeichnung des Dokumentes: Umgang mit Schmerzen in Anlehnung an den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen“ (2014)	

Anwendung von nichtmedikamentösen Schmerztherapien:

- grundsätzlich nur wenn der Patient dies wünscht und unter Umständen hier die Kosten trägt
- bei nichtmedikamentösen Maßnahmen die die Pflegekraft nicht selbst umsetzen kann vermitteln wir soweit möglich fachliche Dritte (Ärzte, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten etc.)
- bei der Umsetzung der nachstehenden Maßnahmen gilt „Versuch und Irrtum“ um heraus zu finden welche Maßnahme von Patienten angenommen wird
- nicht-medikamentöse Maßnahmen die als auslösend für den chronischen Schmerz empfunden werden sind zu vermeiden

Folgende nichtmedikamentöse lindernde und fördernde Schmerztherapien gibt es:

- Aktivierung,
- Motivation, Lebensmotivation, Hoffnung
- Patientenedukation (Weiterbildung) zum chronischen bzw. tumorbedingten Schmerz bspw. Kennen von Ursachen der Chronifizierung, Erlernen von schmerzreduzierenden Verhaltensweisen etc.
- Stärkung der Selbstmanagementkompetenzen (BPI), der Lernmotivation und Veränderungsbereitschaft
- Positives Beeinflussen bestehender sozialer Versorgungssysteme (Angehörige, Nachbarn, Freunde und Bekannte)
- Akupunktur
- Akupressur (Druckpunktmassage)
- Stimulationstherapie (bspw. TEN – transkutane elektrische Nervenstimulation)
- Physikalische Therapie (Wärme/Kälte)
- Krankengymnastik
- Massagen
- psychologische Trainings (autogenes Training, Hypnose, Meditation, geleitete Imaginationen)
- Lagern
- emotionales Ablenken (TV, Humor, Musik, Trost, Zuwendung, Gespräche, Angstvermeidung, Singen, Beten, Nutzung von Aussagen über sich selbst, einen Rhythmus klopfen, taktile Reize durch ungewohnte Oberflächen bspw. Sandpapier, Igelbälle etc.)
- Einsatz von Tieren
- Berührung/Basale Stimulation
- Einbindung physio- und psychotherapeutischer Maßnahmen
- Bei Kindern zusätzlich: Handpuppen, körperliche Aktivitäten, Luftblasen, Arm/Handdrücken/Denkaufgaben, Dinge zählen, Imagination (sich Bilder in der Fantasie vorstellen), Humor, Bilderbücher, Videos, Spiele, Lob und Belohnung, Rollenspiele, Atemübungen, Beiziehung der Eltern, Bäder, Einreibungen
- Bewegung und Mobilisation, schmerzarmes Bewegen, Bewegungsförderung
- Einsatz von Hilfsmittel
- Umfeldgestaltung

Eine Abstimmung mit dem Arzt soll vor allem zu den nichtmedikamentösen Maßnahmen f/g/h/j/k/l/q/s erfolgen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM LIEBE WERDEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 29	Bezeichnung des Dokumentes: Umgang mit Schmerzen in Anlehnung an den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen“ (2014)	

Besonderheiten bei Kindern

- bis zum 5. Lebensjahr ist die KUSS-Skala (Kindliche Unbehaglichkeits- und Schmerzskala in Anlehnung an Büttner) zu verwenden
- ab dem 5. Lebensjahr ist die WBS wie bei Erwachsenen zu verwenden
- mit den Eltern ist eng zusammen zu arbeiten, deren Wünsche, Sorgen und Nöte sind zu berücksichtigen

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Abfall entsorgen
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen/Ablehnung von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung



Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	5	Verw./MA